PROTOCOLE DE RECHERCHE · DOCTORAT EN SANTÉ PUBLIQUE (PH. D.)

# Organiser la réponse intersectorielle aux besoins sociaux complexes et co-occurrents en soins primaires

## Configuration des réseaux adaptés aux différents profils de patients pris en charge




**Eric Bernier**, LL.M. et M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca · erjb-web.github.io
Doctorat en santé publique · Systèmes, organisations et politiques de santé · ESPUM, Université de Montréal

SOUS LA CO-DIRECTION DES
**Dres Nadia Sourial et Géraldine Layani**


## 01 Contexte

**En soins primaires au Canada, 1 patient sur 2 déclare un besoin social** · *Kosowan et al., 2025*

**19 %**
des ménages québécois en insécurité alimentaire en 2023 (14 % en 2018)
*ISQ, 2026*

**40 %**
des ménages qui paient la moitié de leur revenu en logement : se loger ou se nourrir
*ISQ, 2026*

TROIS NOTIONS À DISTINGUER

***La co-occurrence se compte ; la complexité se décrit ; la réponse intersectorielle s'organise sur un territoire.***

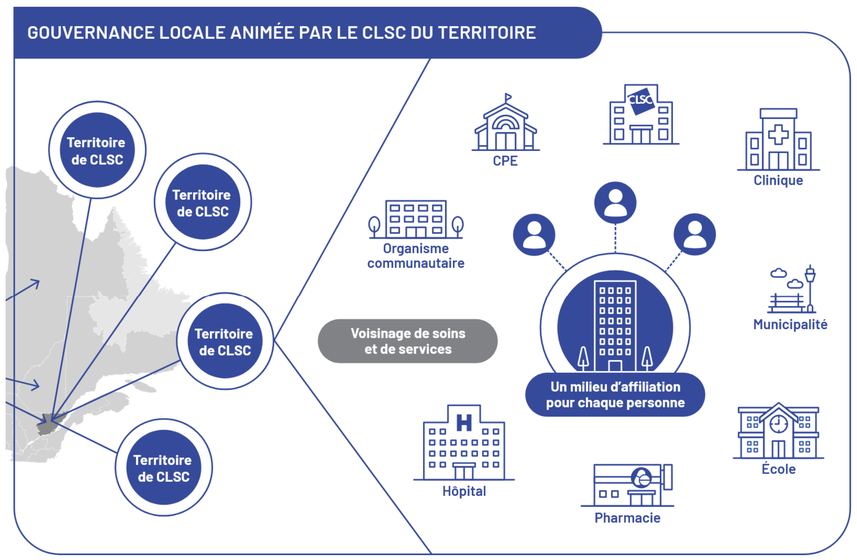
CRITÈRE D'INCLUSION
**Co-occurrence**
Au moins deux besoins sociaux présents en même temps.
*Kreuter et al., 2021*

DÉCRITE, PAS EXIGÉE
**Complexité**
Cumul de maladies chroniques, d'incapacités, de problèmes de santé mentale et de vulnérabilité sociale.
*Kuluski et al., 2017*

S'ORGANISE SUR UN TERRITOIRE
**Réponse intersectorielle**
Actions d'autres secteurs que la santé, menées avec elle, sur la santé ou ses déterminants : CLSC, hôpital, GMF, pharmacies, organismes communautaires, municipalité, écoles, CPE, privé.
*MSSS, 2017 ; Leppo et al., 2013*

POLITIQUE DE PREMIÈRE LIGNE · MSSS, 2026

**Le territoire de CLSC devient l'unité de référence**




QUATRE RÔLES DU CLSC

Navigateur · Coordonnateur · Leader intersectoriel · Coanimateur

*« dans un esprit de gouvernance partagée » · MSSS, 2026, p. 42 · schéma : MSSS, 2026*

MP

EXEMPLE FICTIF · FIL ROUGE
**Mme Protocole** · 58 ans
*Qui répond ? Avec qui ? Qui coordonne ?*

Avis d'expulsion → Insécurité alimentaire → Dettes → Dépression (contexte clinique)

? TROIS LACUNES → TROIS OBJECTIFS

| Profils dispersés, surtout états-uniens ; aucune synthèse | On connaît la programmation, pas les réseaux réellement constitués | Action intersectorielle difficile à organiser et à maintenir |
|---|---|---|
| O1 · Identifier les profils | O2 · Analyser les réseaux | O3 · Recommander |

QUESTION DE RECHERCHE

**Comment s'organise la réponse intersectorielle aux différents profils de patients ayant des besoins sociaux complexes et co-occurrents pris en charge en soins primaires ?**

But : relier chaque profil à… un profil de besoins → une configuration de partenaires → et son coordonnateur

## 02 Méthodes

Terrain : 3 territoires de CLSC contrastés en Lanaudière (défavorisation matérielle de 7 % à 50 % selon la MRC), région pionnière en intersectorialité (table intersectorielle) · devis en plusieurs phases · O2 : SNA mixte séquentielle explicative, déroulée à partir du CLSC

**Quels profils ?**

O1 · IDENTIFIER
**Revue de portée**
4 à 6 vignettes, validées par 6 à 8 acteurs
Études publiées → Profils récurrents → Vignettes
→ des profils devenus vignettes
MP *Son profil est repéré dans les études*

**Qui mobilise qui ?**

O2 · ANALYSER
**Cartographie à partir du CLSC**
3 CLSC, puis les interlocuteurs qu'ils nomment
MP Vignettes réseau potentiel · 12 derniers mois réseau réel
→ réseaux potentiels et réels
MP *Elle devient une vignette*

**Pourquoi et comment ?**

O2 · ANALYSER
**SNA qualitative**
15–25 entretiens · 2 à 3 parcours réels par profil
*« Pourquoi et comment travaillez-vous ensemble ? »*
→ explications des interactions
MP *Son parcours réel est expliqué*

**Que recommander ?**

O3 · RECOMMANDER
**Atelier délibératif**
15–20 participants, dont des patients partenaires
Patients partenaires · Soins primaires · Communautaire · Gouvernance locale · Municipal, privé
→ des recommandations par profil
MP *Son dossier est délibéré en atelier*

**Intégrer**

32 mois · 2026 → 2029
**Tableau conjoint par profil**

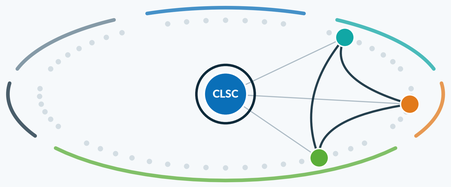
| Profil | Réseau | Pourquoi | Reco. |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |

MP *Des repères pour son profil*

## 03 Résultats anticipés

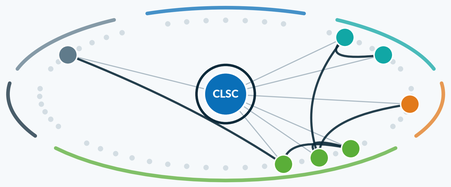
*Exemples fictifs* · **dans chaque CLSC, le réseau égocentré change selon le profil**

**A** Dominante logement
avis d'expulsion



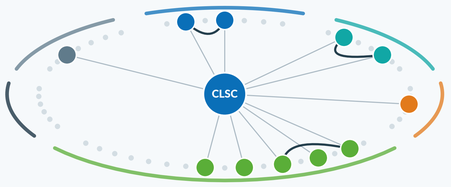

**3** partenaires, tous reliés · le CLSC coordonne

**B** Mme Protocole
logement · alimentation · dettes




**7** partenaires, encore reliés · le CLSC coordonne

**C** Cumul + dépression
mêmes besoins, plus une dépression




**11** partenaires, peu reliés · sans coordonnateur

CLSC (ego) · coordonnateur désigné · lien déclaré par les partenaires · organisation non mobilisée
Santé et services sociaux · Première ligne, pharmacies · Communautaire · Municipal · Éducation, petite enfance · Emploi, justice, privé

H1 **Les secteurs changent** selon le profil → *composition par secteur*
H2 **Un noyau commun,** une périphérie propre → *partenaires communs*
H3 **Plus de partenaires,** mais moins reliés → *taille et densité*
H4 **Le CLSC navigue** et coordonne ? → *coordonnateur désigné*
H5 **Le genre change-t-il** la réponse ? → *versions femme, homme*
≠ **Réel ou potentiel :** quel écart ? → *vignettes vs 12 mois*

## 04 Impacts et retombées

**Pas un « réseau idéal » universel : des repères pour chaque profil.**


**Pour les personnes**
Une réponse ajustée à leur combinaison de besoins


**Pour le CLSC et ses partenaires**
Des repères : qui mobiliser, comment se relier, qui coordonne


**Pour la politique de première ligne**
Un état de départ ; des recommandations selon les quatre rôles du CLSC


**Pour la recherche**
Une hypothèse profil–réseau ; l'écart entre réseaux potentiels et réels

**Diffusion :** restitution aux 3 territoires · protocole publié (OSF) · articles

**Toutes les versions**
FR · EN · ES · 中文 · العربية · Atikamekw · ᐊᓂᔑᓇᐯᒧᐎᓐ · Innu
daltonisme · basse vision · FALC · audio

**Vos idées**
commentaires
lectures
contacts


**Visiter mon site web**


Références : CISSS de Lanaudière, 2024 · Creswell et Plano Clark, 2017 · Gale et al., 2013 · ISQ, 2026 · Kosowan et al., 2025, BMJ Open · Kreuter et al., 2021, Population Health Management · Kuluski et al., 2017, Int J Integr Care · Leppo et al., 2013 · Leutz, 1999 · MSSS, 2017 ; 2026, politique sur les soins et services de première ligne · Peters et al., 2020 · Thorne, 2016